

2. Anamnèse Respiratoire

Outre les principes généraux d'une anamnèse (commencer avec une question ouverte, etc), on retiendra une liste de questions clefs : Toux ? Expectorations ? Douleur thoracique ? Dyspnée ?

Toux

- Caractérisation
- Sèche
- Productive
- Horaire (diurne, nocturne), présence d'accès ou « quintes » de toux ...
- Facteurs déclenchant (surtout pour l'asthme)

Expectorations

- Couleur des crachats (blancs, jaunâtres, verdâtres, brunâtres...)
- Quantité (estimée en nb de mouchoirs utilisés, év. en gobelets remplis)
- Odeur (une odeur fétide peut être due à des germes anaérobies lors d'un abcès pulmonaire...)
- Sang dans les expectorations
- Consistance (mousseuses, collantes, épais, fluide...)

Douleur thoracique

- Localisation
- Reproductible à la palpation
- Respiro-dépendante
- Irradiation (par exemple vers l'épaule en cas d'atteinte de la plèvre diaphragmatique)
- Intensité
- Durée
- Facteurs aggravant (toux, respiration)
- Facteurs soulageant (position)

Dyspnée

- Au repos
- Horaire ? Circonstances ?
- Position ?
- Dyspnée paroxystique nocturne ?
- A l'effort
- Quantifier l'effort (pente, escalier ?)
- Reproductible au même effort ou variable ?
- Définir les stades 1 à 4 selon la New York Heart Association (NYHA)
- Associée à une respiration sifflante ?

La réponse à ces questions-clefs devra être complétée par la présence ou non de signes généraux (asthénie, fièvre, etc) et de signes d'insuffisance cardiaque (œdèmes, nycturie etc.). De plus, une anamnèse respiratoire ciblée doit également intégrer des éléments sur.

- Antécédents personnels et FRCV

- Habitudes (tabac : actuel et UPA, médicaments, alcool, activité physique)
- Anamnèse familiale
- Anamnèse socio-professionnelle
- Anamnèse d'exposition si elle est pertinente au problème (exposition à des maladies infectieuses, environnement professionnel, exposition à des allergènes).

Glossaire

(la définition de ces termes doit être connue de l'étudiant) :

- Tachypnée, bradypné
- Hyperventilation, hypoventilation
- Orthopnée, platypnée
- Hémoptysie, crachats hémoptoïques, hématomèse, épistaxis
- Cyanose, périphérique et centrale
- Stridor
- Hippocratisme digital, ostéo-arthropathie hypertrophique pulmonaire

3. Examen Physique

L'examen physique respiratoire ne peut se faire valablement que chez un patient débarrassé de sa chemise, maillot ou T-shirt, torse-nu pour l'homme, n'ayant gardé que le soutien-gorge pour la femme. L'examen nécessite que le sujet soit couché pour certains aspects (par exemple pour déceler une respiration paradoxale thoraco-abdominale), mais assis pour la plus grande part (percussion, auscultation).

Inspection

Patient couché ou assis

- aspect général : faciès, pâleur, transpiration, agitation etc ?
- bruit anormal de la respiration ? p.ex. stridor inspiratoire, encombrement des voies respiratoires
- fréquence respiratoire (à prendre en faisant semblant de prendre le pouls)
- type respiratoire anormal ? (p.ex. respiration périodique de Cheyne-Stokes)
- respiration lèvres pincées ?
- utilisation des muscles accessoires (SCM, scalènes) ?
- tirage sus-claviculaire et/ou intercostal ?
- orthopnée ? (paralysie bilatérale du diaphragme vs insuffisance cardiaque)
- cyanose ? centrale (sous la langue) ou uniquement périphérique (lèvres, doigts)
- hippocratisme digital ?
- respiration thoraco-abdominale paradoxale ? (paralysie diaphragmatique – ne s'observe qu'en position couchée) ?
- présence d'un volet thoracique ? (chez patient polytraumatisé)

Patient assis

- forme du thorax: diamètre antéro-postérieur augmenté, forme « en tonneau » ?, anomalie anatomique (thorax en entonnoir ou pectus excavatum, thorax en carène ou pectus carinatum) ? orthopédique (cyphose anormalement prononcée, scoliose, cyphoscoliose) ?
- asymétrie du thorax ?
- cicatrices de thoracotomie ? Cicatrice de drain thoracique ?

Palpation (patient assis)

- Ampliation des mouvements thoraciques (vérifier la symétrie du mouvement du thorax pendant une respiration profonde en s'aidant des mains)
- Si le patient mentionne une douleur, la faire localiser précisément avec la main et tenter de la reproduire par la palpation
- Les vibrations vocales : faire dire « 33 » d'une voix grave et sentir les vibrations transmises sur les plages pulmonaires postérieures en appliquant le bord cubital de la main horizontalement et en comparant toujours la plage gauche et la plage droite, à trois différentes hauteurs successivement. (NB : en anglais et en allemand, la transmission des vv se nomme « fremitus ».)

Percussion (patient assis)

- Délimiter la limite inférieure des deux plages pulmonaires, postérieurement (le doigt « plessimètre » est le majeur gauche que l'on applique horizontalement sur le thorax, c'est-à-dire parallèlement à la ligne à délimiter, et qui est percuté sur sa deuxième phalange par l'extrémité du majeur droit, recourbé en marteau – pour les gauchers, l'inverse). Faire une petite marque au stylo pour comparer la hauteur des deux bases (demander au patient la permission !).
- Après avoir délimité les deux bases, comparer la sonorité de la percussion de la plage gauche avec celle de la plage droite, à trois différentes hauteurs, symétriquement, ainsi que dans la région axillaire, symétriquement également.

Nous renonçons à percuter les plages pulmonaires antérieures (sauf pour délimiter le bord supérieur du foie, en position couchée, cf examen de l'abdomen).

- Le son de la percussion peut être « normal » (sonorité pulmonaire normale), ou au contraire se transformer en une matité (semblable au son que l'on observe sur un organe plein comme par exemple sur les reins), ou encore une sub-matité (son intermédiaire), ou à l'inverse un tympanisme (sonore comme sur un tambour, comme on l'observerait sur un estomac gonflé d'air). Matité et sub-matité s'observent typiquement sur un épanchement pleural, une consolidation du parenchyme pulmonaire, une atélectasie. Le tympanisme peut s'observer sur un pneumothorax ou sur une grosse bulle d'emphysème.

Auscultation (à l'aide de la membrane du stéthoscope / patient assis)

- Auscultation postérieure, à trois niveaux de hauteur, puis axillaire et antérieure à un seul niveau de hauteur en général, toujours en comparant symétriquement la gauche et la droite.
- Bruit normal de la respiration : aux bases pulmonaires, le bruit normal de la respiration est décrit par le terme « murmure vésiculaire ». Plus on s'élève, plus le bruit de la respiration se rapproche du bruit trachéal ou glottique, tel qu'on peut l'entendre en posant le stéthoscope sur la tracée au-dessus de la fourchette sternale. Evaluer : 1/ si l'intensité du murmure vésiculaire paraît normale et symétrique ou si elle est diminuée (lors d'emphysème, de pneumothorax...), voire abolie d'un côté (par ex. atélectasie, gros épanchement pleural), ensuite 2/ si la phase expiratoire est anormalement prolongée – « expirium prolongé » (par exemple dans toutes les pathologies obstructives comme l'asthme ou la BPCO).
- Transformation du murmure vésiculaire en souffle tubaire lors de consolidation du parenchyme (ex : pneumonie) : on entend alors le bruit trachéal qui est transmis jusqu'au foyer de consolidation à la place du murmure vésiculaire physiologique.
- Bruits adventices (= bruits pathologiques surajoutés) :
 - Sibilances (son musical haute fréquence) syn. : sifflements, en anglais « wheezing » (ex : asthme)
 - Ronchis (son musical, basse fréquence, comme un ronflement), en anglais « rhonchi » (ex : bronchite)
 - Râles fins (semblables à des craquements, ressemble au « scratch » du velcro) synonymes: râles crépitants, velcro, secs, parenchymateux, en anglais « fine crackles » (ex : pneumonie, fibrose, insuff. cardiaque)
 - Râles grossiers (semblables à des bulles qu'on fait dans l'eau) synonymes : râles bulleux, humides, bronchiques, en anglais « coarse crackles » (ex : bronchite, insuffisance cardiaque au stade de l'œdème aigu du poumon)
- Autres bruits anormaux
 - Frottement pleural : c'est un craquement, audible durant tous le cycle respiratoire, provoqué par de l'inflammation dans la plèvre que l'on a comparé au crissement de chaussures neuves en cuir.
 - Stridor : sifflement respiratoire audible sans stéthoscope et provenant de la trachée ou du larynx.

Origine du bruit de la respiration et des bruits adventices :

Le « murmure vésiculaire » est un terme historique inadéquat. Ce bruit normal de la respiration ne provient pas des alvéoles (les « vésicules » des anciens), mais il représente simplement la transmission atténuée du bruit que font les turbulences de l'air au niveau de la glotte et de la trachée. Lorsque les alvéoles sont remplies de liquide exsudatif (la « consolidation » qui survient dans la pneumonie), le bruit glottique ou trachéal est transmis de manière beaucoup plus intense jusqu'à la périphérie du poumon et on parle alors de « souffle tubaire ».

Les râles fins proviennent de phénomènes survenant au niveau des bronchioles terminales et du parenchyme pulmonaire, alors que les trois autres bruits adventices (râles grossiers, sibilances et ronchis) sont d'origine bronchique et dus en bonne partie aux sécrétions.

Facultatif (ne fait pas partie de l'examen standard)

- Pectoriloquie aphone (faire chuchoter « 66 » : on entend un bruit sonore avec le stéthoscope, alors que le patient ne fait que chuchoter).
- Egophonie (faire dire « iiiii », on entend « ééé » avec le stéthoscope. Survient lors de consolidation, par ex : pneumonie. Ces deux phénomènes résultent du même mécanisme de transmission altérée des sons que pour le souffle tubaire.

3.1. Quelques exemples

Pneumonie (sans épanchement pleural associé) : à la hauteur du foyer de pneumonie on peut trouver une sub-matité à la percussion, les vibrations vocales sont augmentées (meilleure transmission du son par le parenchyme consolidé) et on ausculte un souffle tubaire avec des râles fins inspiratoires.

Epanchement pleural : on percute une sub-matité ou une matité, selon l'importance de l'épanchement, les vibrations vocales sont diminuées et le murmure vésiculaire est aboli en regard de l'épanchement. Il n'y a pas de râle ni d'autres bruits adventices.

Crise d'asthme : la percussion est normale, les vibrations vocales sont normales, le murmure vésiculaire est diffusément diminué d'intensité et l'expirium est prolongé. On entend des sibilances dispersées sur les deux plages pulmonaires avec éventuellement quelques ronchis.

Fibrose pulmonaire : percussion normale, vibrations vocales normales, murmure vésiculaire normal et symétrique. Présence de râles fins, symétriquement et diffusément, sur les deux plages pulmonaires inférieures (la fibrose prédomine en générale aux bases pulmonaires.).

Pneumothorax du poumon droit : percussion tympanique sur la page pulmonaire droite avec abolition de la transmission des vibrations vocales et abolition du murmure vésiculaire.